

Finerenón naprieč štádiami kardiovaskulárno-obličkovo-metabolického (CKM) syndrómu u pacientov s DM2 a CKD: čo prináša post-hoc analýza FIDELITY

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščin · Publikované: 01.07.2026

Pacienti s diabetes mellitus 2. typu (DM2) a chronickou chorobou obličiek (CKD) tvoria skupinu s vysokým rizikom kardiovaskulárnych aj renálnych príhod. V praxi je však diagnostika a riziková stratifikácia často „fragmentovaná“: nefrológ rieši obličky, kardiológ srdce a metabolické faktory idú mimo hlavného rozhodovacieho rámca.

V tomto kontexte dáva zmysel koncept CKM syndrómu (cardiovascular-kidney-metabolic), ktorý spája obezitu/metabolické riziká, diabetes, CKD a kardiovaskulárne ochorenie do jedného klinického rámca. Medscape článok sumarizuje výsledky post-hoc analýzy dvoch randomizovaných FIDELITY štúdií, v ktorej sa hodnotilo, či liečba finerenónom prináša konzistentný prínos naprieč CKM štádiami.

Dizajn a populácia

- Ide o **post-hoc združenú (pooled) analýzu dvoch fáz 3 randomizovaných, dvojito zaslepených, placebo kontrolovaných štúdií FIDELITY**.
- Zaradených bolo **12 990 pacientov** (priemerný vek 64,8 roka; 70 % mužov), so sérovým **K⁺ ≤ 4,8 mmol/l** a liečených **maximálne tolerovanou inhibíciou RAAS**.
- Symptomatické **HFrEF** boli zo štúdií vylúčené.
- Pacienti boli podľa **CKM štádia východiskovo** rozdelení na:
 - **štádium II**: metabolické rizikové faktory alebo stredné až vysoké riziko CKD (n = 3864)
 - **štádium III**: veľmi vysoké riziko CKD (n = 3275)
 - **štádium IV**: klinické kardiovaskulárne ochorenie (n = 5851)
- Primárne sledované boli:
 - **kardiovaskulárny kompozit** (kardiovaskulárna smrť, nefatálny IM, nefatálna CMP, hospitalizácia pre zlyhávanie srdca)
 - **renálny kompozit** (zlyhanie obličiek, pretrvávajúci pokles eGFR o ≥ 57 % oproti východisku po ≥ 4 týždňoch alebo smrť z renálneho zlyhania)
- Medián sledovania bol **3 roky**.

Kľúčové výsledky

1) Vyššie CKM štádium znamená vyššie riziko

CKM **štádium IV** bolo spojené s vyšším rizikom oproti štádiu II:

- **kardiovaskulárny kompozit**: aHR **1,87** (95 % IS 1,56–2,24)
- **renálny kompozit**: aHR **1,96** (95 % IS 1,43–2,69)

To zodpovedá klinickému očakávaniu, ale dôležité je, že rámec CKM štádia sa správa konzistentne aj v prostredí klinického skúšania.

2) Finerenón znižoval riziko nezávisle od CKM štádia

Finerenón znížil:

- **kardiovaskulárny kompozit** aj pri rôznych CKM štádiách (P pre interakciu **0,86**)
- **renálny kompozit** naprieč CKM štádiami (P pre interakciu **0,65**)

Čiže prínos bol „robustný“ naprieč východiskovým rizikovým profilom podľa CKM.

3) Okrem prínosu v príhodách: aj priaznivejšia dynamika CKM

V skupine na finerenóne sa pozorovala priaznivejšia zmena CKM stavu v čase:

- **CKM regresia zo štádia III do II:** vyššia pravdepodobnosť pri finerenóne (odds ratio 1,66; **P < 0,001**)
- **CKM progresia:** menej častá, ale štatisticky to vyšlo len na hranici (aOR 0,89; **P = 0,05**)

4) Bezpečnosť naprieč CKM štádiami

Bezpečnostný profil finerenónu bol **podobný naprieč CKM štádiami** a nebol pozorovaný diferencovaný nárast rizika **hyperkaliémie podľa štádia**.

Prečo je to zaujímavé pre nefrológiu

Z nefrologického pohľadu je prakticky dôležité, že tento výsledok podporuje myšlienku, že finerenón nie je „len renálny“ liek alebo „len kardiálny“ liek, ale pravdepodobne zasahuje spoločné dráhy, ktoré vedú k renálnym aj kardiovaskulárnym príhodám. CKM rámec navyše naznačuje, že pacient môže mať komplexné riziko aj bez toho, aby bolo v klinickej dokumentácii explicitne pomenované ako jedna jednotka.

Napriek tomu treba mať na pamäti, že ide o post-hoc analýzu a nie primárny cieľový ukazovateľ štúdie pre CKM štádiá.

Limity a interpretácia opatrne

Medscape aj pôvodná práca zdôrazňujú obmedzenia:

- **FIDELITY štúdie neboli pôvodne dizajnované na skúmanie účinkov finerenónu na CKM syndróm**, takže niektoré podskupiny majú obmedzené počty a nie všetky potrebné premenné boli systematicky zbierané pre úplnú klasifikáciu CKM štádií.
- Post-hoc charakter znižuje istotu kauzality a robí z výsledkov skôr potvrdenie konzistencie než „definitívny dôkaz“ pre CKM rámec ako liečebný cieľ.

Záver

V post-hoc združenej analýze FIDELITY finerenón **znižoval kardiovaskulárne aj renálne príhody konzistentne naprieč CKM štádiami** u pacientov s DM2 a CKD. Štádium IV bolo spojené s vyšším rizikom, no prínos finerenónu sa ukázal aj u pacientov s vyššou východiskovou záťažou. Navyše sa pozorovala priaznivejšia dynamika CKM (regresia zo štádia III do II) a bezpečnosť vrátane rizika hyperkaliémie bola porovnateľná naprieč štádiami.

Zdroj: Kevin Bryan Lo, John W. Ostrominski, et al. (FIDELITY post-hoc analýza), *JAMA Cardiology* (2026) — spracované v *Medscape Medical News*: „Finerenone Benefits Patients With T2D, CKD Across Cardiovascular-Kidney-Metabolic...“. [Medscape](#) · [PubMed](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=finerenon-ckm-syndrom-dm2-ckd-fidelity> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.